

TEMA 5.17 • HEMATOLOGÍA

Hemofilia

PERFIL EUNACOM 1.07.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hemofilia

Definición

Déficit congénito de factores de coagulación de la **vía intrínseca** → alteración de hemostasia secundaria.

TABLA 5.17.1: TIPO VS FACTOR DEFICITARIO		
TIPO	FACTOR DEFICITARIO	HERENCIA
Hemofilia A	Factor VIII	Ligada al X (recesiva)
Hemofilia B	Factor IX	Ligada al X (recesiva)

EUNACOM CRITERIOS

Solo hombres tienen hemofilia A y B. Las mujeres son portadoras (1 X alterado + 1 X sano → no sangran, pero transmiten).

Clínica

- **Hemostasia secundaria:** hematomas profundos, **hemartrosis** (sangrado articular)
- **Epistaxis**, hemorragia neonatal (cefalohematoma, hemorragia intracerebral)
- Presencia desde el nacimiento
- Antecedentes familiares frecuentes (tíos, primos afectados)

Diagnóstico

- **TTPK ↑** (ambos tipos alargan la vía intrínseca)
- Medir **Factor VIII** (hemofilia A) o **Factor IX** (hemofilia B) — actividad < 40% = diagnóstico
- TP/INR: **normal**

Gravedad

- Leve: factor > 5%
- Moderada: 1-5%
- Grave: < 1% → hemartros espontáneo

Tratamiento

- **Factor VIII EV** periódico → hemofilia A
- **Factor IX EV** periódico → hemofilia B

Mujer portadora

- No sangra (tiene el X sano compensador)
- 50% de sus hijos → hemofílicos
- 50% de sus hijas → portadoras

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Recién nacido varón con cefalohematoma extenso y antecedente de tío materno fallecido por hemorragia. TTPA alargado, TP normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hemofilia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hemofilia A (factor VIII) y B (factor IX) son ligadas al cromosoma X: solo hombres
- Clínica desde el nacimiento: hemorragias neonatales, luego hematomas y hemartrosis de por vida
- El TTPA está alargado en ambos tipos de hemofilia (primer examen a solicitar)
- Diagnóstico: actividad del factor <40% confirma hemofilia
- Tratamiento: factor VIII (hemofilia A) o factor IX (hemofilia B) endovenoso
- Mujer portadora: sin riesgo personal, pero 50% de hijos hemofílicos y 50% de hijas portadoras

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HEMOFILIA)

PREGUNTA 1

Recién nacido varón con cefalohematoma extenso y antecedente de tío materno fallecido por hemorragia. TTPA alargado, TP normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) PTI neonatal
- B) Enfermedad de von Willebrand
- C) Hemofilia
- D) CID
- E) Déficit de vitamina K del recién nacido

PREGUNTA 2

¿Cuál es el punto de corte de actividad del factor de coagulación para diagnosticar hemofilia?

- A) <10%
- B) <20%
- C) <30%
- D) <40%
- E) <50%

PREGUNTA 3

Mujer portadora de hemofilia A consulta por consejo genético. ¿Cuál es la información correcta?

- A) Ella tiene 50% de probabilidad de presentar hemorragias
- B) Todos sus hijos varones serán hemofílicos
- C) Ninguna de sus hijas será portadora
- D) 50% de sus hijos varones serán hemofílicos y 50% de sus hijas serán portadoras
- E) Debe recibir factor VIII profiláctico

RESUMEN: HEMOFILIA

Esta clase cubre la hemofilia de manera breve. La hemofilia A (factor VIII) y B (factor IX) son enfermedades ligadas al cromosoma X, que se ven solo en hombres. La clínica se manifiesta desde el nacimiento con hemorragias (cefalohematoma, hemorragia intracerebral) y persiste toda la vida como alteración de hemostasia secundaria severa: hematomas, hemartrosis, epistaxis. El diagnóstico se hace midiendo la actividad del factor deficiente (punto de corte: 40%). Ambos tipos alargan el TTPA, que es el primer examen a solicitar. El tratamiento consiste en administrar el factor deficiente (VIII o IX) por vía endovenosa. Para mujeres portadoras (un X con hemofilia, otro sano): no tienen riesgo personal de sangrado, pero la mitad de sus hijos serán hemofílicos y la mitad de sus hijas portadoras.